

Test 1.2

1.* Les contre-indications à la paracentèse sont les suivantes sauf :

- a) Patients dont l'état général est altéré
- b) Abdomen chirurgical aigu
- c) Diathèse hémorragique
- d) Grossesse ou gros kystes ovariens
- e) Collections liquides volumineuses qui provoquent des troubles hémodynamiques et respiratoires dus à la compression du diaphragme ou de la veine cave inférieure

D

2.* Dans la définition de la constipation, le critère du nombre de selles hebdomadaires (selles par semaine) fait référence à :

- a) Une évacuation hebdomadaire ou moins
- b) Deux évacuations hebdomadaires ou moins
- c) Trois évacuations hebdomadaires ou moins
- d) Quatre évacuations hebdomadaires ou moins
- e) Moins d'une évacuation quotidienne

B

3.* Les objectifs pour le traitement des escarres sont les suivants sauf :

- a) Contrôle de la douleur et de l'inconfort
- b) Augmentation de la mobilité articulaire et de la force musculaire
- c) Prévenir l'infection des escarres
- d) Contrôle des odeurs et des exsudats
- e) Réduction des saignements

B

4.* L'irritation cutanée est le plus souvent causée par une fuite de matériel stomatique, les causes les plus fréquentes étant les suivantes sauf :

- a) érythème
- b) Érosion
- c) Macération
- d) Dermate de contact
- e) Tumeur maligne de la peau

C

5.* Les techniques d'auto-soins et d'exercices pour le lymphœdème comprennent les suivantes :

- a) Bandage compressif
- b) Exercices isométriques
- c) Auto-massage de drainage lymphatique
- d) Élévation du membre atteint
- e) Contrôle du poids corporel

P

6.* Les examens d'imagerie pour le diagnostic positif et différentiel du lymphœdème comprennent les éléments suivants, sauf :

- a) Échographie / écho Doppler
- b) TDM
- c) IRM
- d) Lymphoscintigraphie

E

☒ e) endoscopie veineuse

7.* L'étiopathogénie du lymphoedème secondaire est représenté par les suivantes causes sauf :

- a) Augmentation de l'apport en protéines
- b) Une intervention chirurgicale
- c) La radiothérapie
- d) Une neoplasie
- e) Une infection

C

8.* La phase proliférative de la cicatrisation (escarres) est représenté par :

- a) Migration des leucocytes
- b) Enlèvement des tissus morts
- c) Infiltration de la plaie avec de nouveaux vaisseaux sanguins soutenus par du tissu conjonctif
- d) Réorganisation du tissu conjonctif
- e) La formation des phlicènes

B

9.* Selon le degré d'évolution des ulcères de décubitus, un patient présentant un érythème, une microcirculation altérée, des écorchures superficielles et des phlyctènes :

- a) stade 1
- b) stade 2
- c) stade 3
- d) stade 4
- e) stade 5

D

10.* Les facteurs extrinsèques prédisposant aux ulcères de décubitus sont les suivants sauf :

- a) Incontinence, transpiration
- b) alitement prolongé
- c) mauvaise hygiène (peau, literie)
- d) antibiotiques
- e) l'humidité (pellicule plastique ou chiffon)

D

11.* Il existe une susceptibilité au lymphoedème chez les patients atteints des néoplasmes, sauf :

- a) les tumeurs du tête et cou
- b) le tube digestif
- c) sein
- d) gynécologique
- e) mélanome

A

12.* Le traitement du lymphoedème clinique précoce repose sur :

- a) compression (manchon de compression)
- b) traitement décongestionnant complet
- c) thérapie pneumatique
- d) chirurgie de drainage lymphatique
- e) mise sous vide

A

13.* En cas de lymphoedème, selon l'indice de gravité volumique, une augmentation de 15 % est incluse comme :

B

- a) Le lymphœdème est absent
- ☒ b) Lymphœdème minime
- c) Lymphœdème léger
- d) Lymphœdème modéré
- e) Lymphœdème sévère

14. * Mesures de soins et de traitement pour les œdèmes légers :

- ☒ a) Diurétiques (furosémide)
- b) Lifting (soulever le membre affecté)
- c) Pompe à compression pneumatique intermittente
- d) Réchauffement du membre affecté
- e) Endoprothèse veineuse

B

15. * Parmi les mécanismes physiopathologiques de l'œdème figurent les suivants, sauf :

- a) Augmentation de la pression oncotique interstitielle
- b) Augmentation de la pression hydrostatique capillaire
- c) Diminution de la pression hydrostatique interstitielle
- d) Perméabilité capillaire accrue
- e) Faible apport en sodium

B

16. * Les éléments suivants sont valables pour l'œdème périphérique :

- a) Elle peut être causée par des compressions ou une thrombose des artères
- b) est défini comme une accumulation intravasculaire de liquide
- c) représente une accumulation de liquide dans les tissus infusés par la circulation périphérique
- d) l'un des mécanismes physiopathologiques est une augmentation de la pression artérielle
- e) l'un des mécanismes physiopathologiques est la diminution de la pression oncotique interstitielle

C

17. Les éléments suivants peuvent être recommandés pour le traitement de la constipation :

- ☒ a) Augmenter l'apport en fibres alimentaires
- b) Imodium
- c) Argiles protectrices
- d) Lactulose
- ☒ e) Traitement chirurgical - réservé à la constipation secondaire par obstruction

18. Médicaments pouvant causer de la constipation :

- ☒ a) Préparations de calcium
- b) Bloqueurs de canaux calciques
- c) Préparations de fer
- ☒ d) Analgésiques opioïdes
- e) Bisacodyl

19. Maladies dans lesquelles se manifeste la constipation secondaire :

- a) Hyperthyroïdie
- ☒ b) Hypothyroïdie
- c) Hypercalcémie
- ☒ d) Hypocalcémie

e) Tumeurs du côlon ou du rectum

20. Constipation habituelle :

- ☒ a) Elle est moins fréquente que la constipation symptomatique (secondaire) b) C'est la forme la plus courante de constipation
- c) Il survient plus fréquemment chez les hommes
- ☒ d) Il survient plus fréquemment chez les femmes
- e) Elle est favorisée par les erreurs alimentaires

21. Pour définir la constipation, les éléments à considérer sont :

- a) La durée de la symptomatologie est supérieure à 3 jours
- b) La durée de la symptomatologie est supérieure à 3 semaines
- c) La durée de la symptomatologie est supérieure à 3 mois
- d) Augmentation de la consistance des selles à plus de 25 % des émissions
- e) Effort de défécation ou sensation d'évacuation incomplète à plus de 25% des émissions

22. Pour le traitement de la diarrhée on peut envisager :

- a) Le bisacodil
- b) Sulfate de magnésium intraveineux
- c) Imodium
- d) Augmenter l'apport en fibres
- e) Argiles protectrices

23. Diarrhée chronique :

- a) Il a une durée de manifestation de plus de 5-7 jours
- ☒ b) Il dure plus de 4 semaines
- c) L'évaluation du contexte épidémiologique indiquera l'agent causal dans la plupart des cas
- ☒ d) Elle doit être différenciée de l'incontinence fécale (élimination involontaire des matières fécales lorsque la consistance des selles est plus liquide)
- e) Il doit être traité avec des antibiotiques en association pendant 10 à 14 jours

24. Diarrhée aiguë (plus de 3 selles non formées en 24 heures) :

- ☒ a) Il peut durer jusqu'à 3 jours
- ☒ b) Cela peut durer au maximum 2-3 semaines
- c) En cas de diarrhée infectieuse, la présence de sang et de leucocytes dans les selles est un signe de gravité.
- d) En cas de diarrhée infectieuse, le contexte épidémiologique sera analysé e) En cas d'absence de signes de gravité, la réhydratation et l'antibiothérapie sont utilisées en association pendant 7 jours.

25. La diarrhée sécrétoire survient :

- ☒ a) Médicaments induits par les laxatifs (bisacodil)
- b) Induit par des composés organophosphorés
- c) Induit par des entérotoxines bactériennes (vibrio cholerae)
- ☒ d) Ingestion de sulfate de magnésium pour le suicide
- ☒ e) En cas de tumeurs productrices d'hormones

26. La diarrhée osmotique survient :

- ☐ a) En raison d'un écoulement d'eau de la paroi intestinale dans la lumière, afin d'isotoniser le contenu intestinal
☒ b) Induit par des entérotoxines bactériennes (vibrio cholerae)
☐ c) Ingestion de champignons vénéneux
☒ d) En raison de l'ingestion de polyéthylène glycol, de sorbitol, mannitol, lactulose, sulfate de magnésium
☐ e) cas de malabsorption du glucose - galactose ou fructose
27. La définition du syndrome diarrhéique prend en compte :
- ☒ a) Nombre de selles (nombre d'évacuations) par jour
☒ b) La consistance des selles
☐ c) Augmentation de la quantité de matière émise en 24 heures (augmentation du poids des selles)
☒ d) Effort de défécation à plus de 25 % des émissions
☒ e) Sensation d'échappement incomplète à plus de 25% des émissions
28. Mesures utiles pour la prévention des escarres:
- ☒ a) Hygiène générale, évaluation et traitement de l'incontinence, observation régulière des points de pression
☐ b) Réduction du cisaillement, de la pression (mobilisation passive toutes les deux heures, utilisation de matelas spéciaux)
☒ c) Mobilisation des patients
☐ d) Contrôle de la douleur
☒ e) Antibiothérapie prophylactique
29. L'utilisation d'antiseptiques dans la plaie (escarre) doit tenir compte de leurs effets secondaires potentiels :
- ☐ a) Les solutions à base de chlore peuvent être toxiques pour les tissus granuleux, maintenir l'inflammation des plaies, irriter la peau saine
☒ b) Peroxyde d'hydrogène : détruit le tissu de granulation, macère une peau saine
☐ c) Le peroxyde d'hydrogène provoque souvent des réactions allergiques
☐ d) Les solutions chlorées sont associées à un risque d'embolie
☐ e) La povidone iodée peut retarder la cicatrisation
30. Utilisation du lavage (irrigation) pour nettoyer les plaies (escarres) :
- ☐ a) Élimine les micro-organismes de la plaie
☒ b) Enlève les corps étrangers de la plaie
☐ c) Il sera fait avec des fluides froids pour prévenir la douleur
☒ d) Cela se fera avec des fluides à température corporelle
☐ e) Cela se fera avec des fluides chauffés à 45 -47 degrés Celsius pour un effet antibactérien
31. Utilisation de tampons pour nettoyer les plaies (escarres) :
- ☒ a) Élimine efficacement les bactéries de la plaie
☐ b) Au contraire, il redistribue les bactéries à la surface de la plaie
☒ c) Stimule la formation de tissu de granulation
☐ d) Peut causer un nouveau traumatisme, détruisant le tissu granuleux
☐ e) Il peut laisser de fines fibres dans la plaie qui maintiennent l'inflammation
32. Le principe de cicatrisation plus rapide des escarres en milieu humide attribue les actions suivantes à l'exsudat de la plaie :
- ☒ a) Laver la plaie et la garder humide

- b) C'est un bon milieu de culture pour les bactéries, favorisant leur multiplication c) En raison de sa teneur en leucocytes, il combat les bactéries
d) Fournit des conditions optimales pour la migration des cellules épithéliales et la mitose
e) Il a une action thrombotique sur la microcirculation et limite les hémorragies

33. Facteurs qui retardent la cicatrisation des escarres :

- a) Apport d'albumine
b) Transfusion
c) Corps étrangers dans la plaie
d) Présence d'infection et de sécrétions purulentes
e) Stéroïdes volumineux ou à action prolongée

34. Une escarre de grade 4 peut présenter

- a) Lésions limitées au tissu sous-cutané
b) Affectant le fascia profond
c) Dommages musculaires
d) Les lésions peuvent atteindre l'os
e) fistules

35. Les facteurs intrinsèques de prédisposition aux ulcères de décubitus sont :

- a) déficit neurologique
b) épilepsie
c) cancer, diabète, septicémie
d) obésité, cachexie
e) sédation

36. Les escarres de decubitus

- a) Elles résultent de troubles de la circulation sanguine et lymphatique au niveau de la peau et des tissus sous-jacents
b) Ils sont le résultat d'une exposition prolongée des extrémités à des températures inférieures à 20 degrés Celsius
c) Le mécanisme de la circulation altérée est la compression et le cisaillement d) Le mécanisme de la circulation altérée est la vasoconstriction
e) Le mécanisme de la circulation altérée est l'hypothermie locale

37. Lors du remplacement de la collerette du dispositif stomatique, vous devez :

- a) Examinez la peau autour de la stomie à la recherche de rougeurs ou de dommages b) Examinez l'arrière de la bride (pour l'érosion ou le liquide stomatique) c) Le patient doit être allongé en décubitus dorsal (clinostatisme)
d) Pour que le patient s'allonge sur le dos
e) Pour que le patient soit couché sur le dos, orthostatique ou assis

38. Pour prévenir l'irritation de la peau dans les systèmes de l'estomac :

- a) Les appareils seront changés régulièrement
b) L'adhésif (bride) se décollera doucement
c) L'adhésif (bride) se détachera en une manœuvre rapide
d) Les appareils seront remplacés en cas de crevaisson ou de brûlure e) Il est

recommandé de ne remplacer l'appareil qu'en cas de fuite

39. La bride du système gastrique :

- a) Doit être appliqué sur peau sèche
- b) Doit être appliqué sur peau humide immédiatement après le lavage à l'eau et au savon
- c) Doit être appliqué sur la peau après application d'une crème antibiotique
- d) Doit être appliqué sur la peau après application d'une solution désinfectante
- e) Il doit être coupé pour s'adapter à la taille et à la forme de la stomie

40. Un bon adhésif du système stomatique doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- a) Avoir une emprise sur la peau
- b) N'absorbe pas le liquide sur la peau
- c) Ne soit pas irritant
- d) Être sans odeur et sans goût
- e) Être facile à enlever

41. Dans le cas des personnes ayant des stomas/systèmes stomatiques (colostomie, iléostomie) :

- a) La pénétration de substances intestinales sous la collerette peut provoquer des fuites
- b) La plupart des irritations cutanées péristomiales sont dues à des réactions allergiques à l'adhésif
- c) La plupart des irritations cutanées sont dues à un écoulement de la stomie d) Initialement, le contenu de la stomie passe sous la collerette puis sur les vêtements
- e) L'éclatement des poches est la principale cause d'irritations cutanées

42. Pratiques pour réduire le risque de lymphœdème :

- a) De préférence, la ponction veineuse sur le membre à risque de lymphœdème doit être évitée
- b) Les mesures de la pression artérielle sur le membre à risque de lymphœdème doivent être évitées
- c) Utilisation de l'aspirateur pendant le vol sur le membre à risque de lymphœdème
- d) Port de gants ou de bandages compressifs dans l'avion sur le membre à risque de lymphœdème
- e) Application quotidienne de crèmes stéroïdiennes et éviter les bains sur le membre à risque de lymphœdème

43. Une susceptibilité accrue au lymphœdème survient chez les patients atteints de néoplasmes :

- a) Bronchopulmonaire
- b) Le tube digestif
- c) Sein
- d) gynécologique
- e) mélanome

44. La prévention du lymphœdème chez les personnes à risque comprend les indications suivantes :

- a) S'abstenir de tout exercice
- b) Exercices spécifiques prescrits individuellement
- c) Éviter l'obésité qui est un facteur de risque de lymphœdème secondaire d) Évitement total de l'exposition au soleil
- e) Crèmes anti-inflammatoires

45. Les examens de laboratoire pour le diagnostic positif et différentiel du lymphœdème comprennent :

- a) la fonction thyroïdienne
- b) spirométrie
- c) examen doppler carotidien
- d) la fonction hépatique
- e) fonction rénale

46. Stadification du lymphœdème selon la fibrose tissulaire (stades 0 à 3) - les éléments suivants sont corrects :

- a) Stade 0 : subclinique (latente), avec le potentiel de devenir cliniquement évident b) Stade 1 : signe du godet positif, dépôts fibrogras sous-cutanés, distorsion architecturale, lymphœdème irréversible en élévation
- c) Stade 2 : signe du godet positif et réversible en élévation
- d) Stade 3 : excroissances dermiques verruqueuses, distorsion architecturale sévère e) Stade 3 signe du godet négatif en raison de la induration

47. Les mesures pour le traitement de l'œdème comprennent:

- a) Applications diurétiques locales
- b) Mouvement du membre affecté
- c) Élévation de la partie affectée
- d) Massage ferme, en particulier dans les thrombophlébites profondes e) Réduction
- e) la consommation de sel

48. Enquêtes utiles dans l'évaluation des œdèmes:

- a) Capillaroscopie
- b) Capillarographie
- c) Échographie Doppler veineuse
- d) Examen sommaire des urines
- e) IRM (résonance magnétique nucléaire)

49. Les maladies associées à une diminution de la pression oncotique plasmatique sont :

- a) Régime hyposodique
- b) Malnutrition
- c) Thrombose veineuse profonde
- d) Le syndrome néphrotique
- e) Insuffisance hépatique

50. Parmi les mécanismes physiopathologiques de l'œdème figurent:

- a) Diminution de la pression oncotique plasmatique
- b) Diminution de la pression oncotique interstitielle
- c) Augmentation de la pression oncotique plasmatique
- d) Augmentation de la pression oncotique interstitielle
- e) Diminution de la perméabilité capillaire